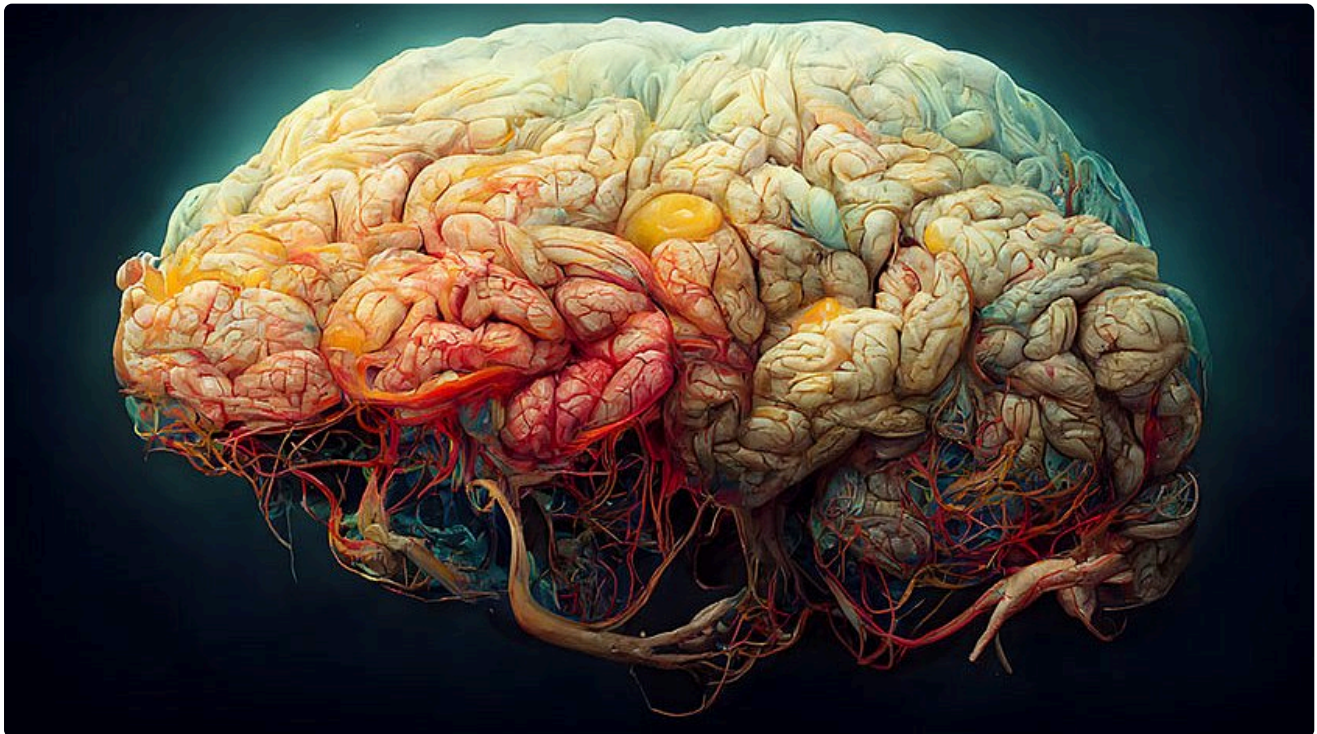


Live

Справочник
Заболевания

Сосудистые заболевания мозга



Юлия Голубева

4.1

Сосудистые (или цереброваскулярные) заболевания головного мозга — это общее название состояний, при которых мозг временно или permanently недополучает кислорода и питательных веществ. Эти состояния опасны: они могут привести к снижению памяти и работоспособности, вплоть до развития деменции (слабоумия), потере контроля над физиологическими процессами в теле и даже смерти.

Содержание

- Кровоснабжение головного мозга
- Виды сосудистых заболеваний головного мозга
- Причины сосудистых заболеваний головного мозга
- Причины заболеваний сосудов
- Симптомы заболеваний сосудов головного мозга
- Диагностика заболеваний сосудов головного мозга
- Лечение заболеваний сосудов головного мозга
- Осложнения заболеваний сосудов головного мозга
- Источники

Новые скидки в Клубе!

Промокоды до 25%, секретные распродажи, призы и подарки! →

Каждый месяц дарим подарки и делаем скидки до 30% 🎁
Начните экономить прямо сейчас!

Фамилия

Имя

Дата рождения

День

Месяц

Год

Сайт защищен reCAPTCHA и Google. [Конфиденциальность](#) и [Условия использования](#).

Даю согласие

☐ На обработку ПДн



☐ На получение писем



Подписаться

Кровоснабжение головного мозга

Мозг человека питают четыре артерии — две сонные (проходят по бокам передней части шеи) и две позвоночные (расположены с двух сторон от позвоночника).

Каждая из них отвечает за питание отдельной области: лобных, височных, теменной и затылочных долей, а также ствола мозга и мозжечка.



Головной мозг питают две сонные и две позвоночные артерии

Если какая-то артерия выходит из строя, предусмотрен защитный механизм: у основания мозга ответвления артерий образуют замкнутый круг и при необходимости компенсируют работу друг друга. Но компенсаторные механизмы небесконечны, поэтому очень важно поддерживать сосуды головы в рабочем состоянии.

Для нормальной работы мозгу требуется около четверти объёма вдыхаемого кислорода.

Если кровоток ограничен, питание мозга ухудшается, и это может приводить к головным болям, головокружению, снижению работоспособности и нарушению памяти, а в особо тяжёлых случаях — к параличу, коме или смерти.

При нарушении кровообращения в мозге очень важно обратиться за помощью как можно скорее, чтобы не допустить необратимых последствий или минимизировать их.

Виды сосудистых заболеваний головного мозга

Среди сосудистых заболеваний головного мозга выделяют острые и хронические состояния.

Острая патология — это инсульт. Он может возникать на фоне закупорки сосудов

отмирают, а вместе с ними человек утрачивает работоспособность повреждённых отделов мозга.

Геморрагический инсульт (внутри мозговое кровоизлияние) возникает в результате разрыва сосуда и кровоизлияния в мозг. Проникая к клеткам мозга, кровь раздражает и повреждает их, приводя к гибели.



При геморрагическом инсульте происходит разрыв сосуда, что приводит к гибели клеток мозга

Хроническая патология — это ишемия головного мозга: прогрессирующее ухудшение кровообращения, которое сопровождается нарушением питания тканей мозга. При хроническом течении болезни ухудшение состояния развивается медленно, в течение нескольких месяцев или лет, так как кровоток частично сохранён.

Стадии хронической ишемии мозга (ХИМ):

- лёгкая: отмечаются незначительные нарушения работы мозга. Трудоспособность сохранена, человек может обслуживать себя сам в быту;
- средняя: умеренные нарушения работы мозга. Трудоспособность утрачена, может потребоваться присмотр и помощь в быту;
- тяжёлая: работа мозга сильно нарушена (деменция), человек не может себя обслуживать и жить один.

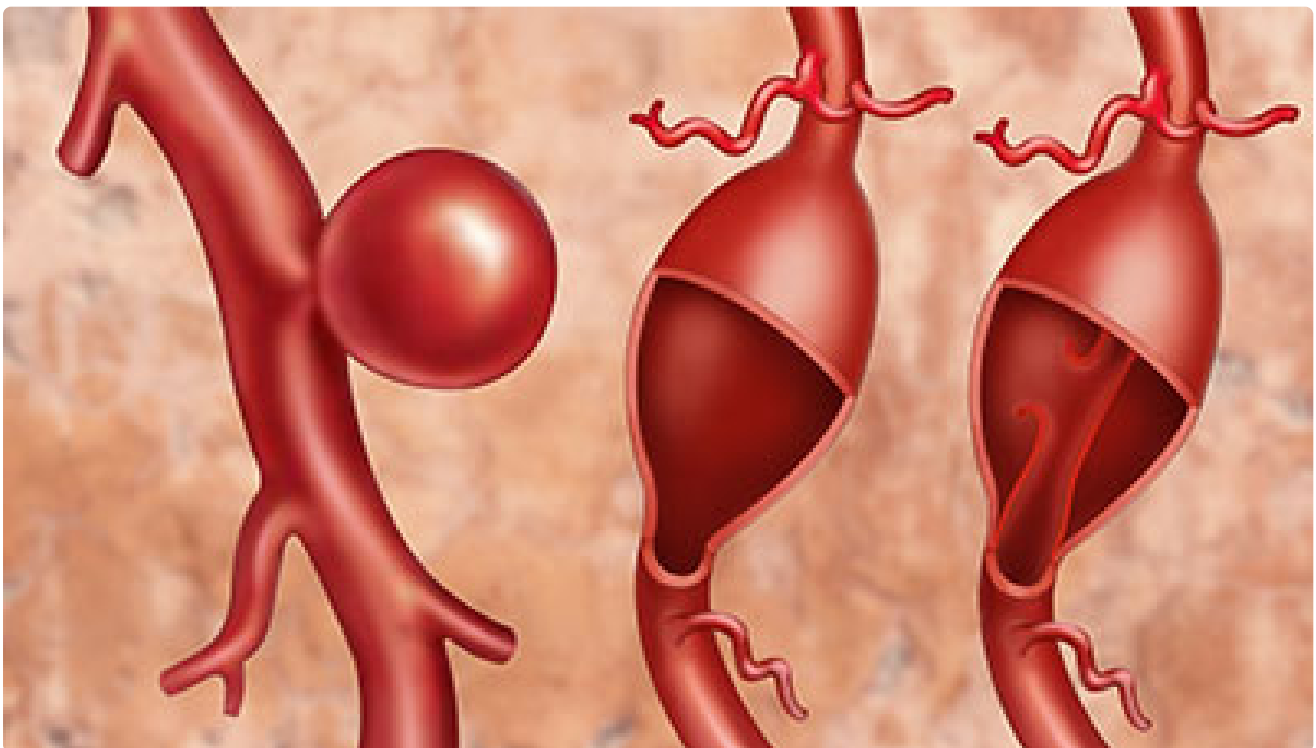
Причины сосудистых заболеваний головного мозга

Острая или хроническая недостаточность кровоснабжения может возникать в результате немодифицируемых и модифицируемых факторов риска.

Немодифицируемые факторы риска

Немодифицируемые (то есть такие, на которые невозможно повлиять) факторы риска сосудистых заболеваний мозга включают генетические нарушения и аномалии строения сосудов. Они могут долгое время существовать без симптомов и приводить к опасным состояниям, в том числе к смерти.

Церебральная аневризма — растяжение или истончение стенки артерии, которое приводит к её выпячиванию и повышает риск разрыва сосуда. Как правило, аневризма — это врождённая патология, ассоциированная с некоторыми наследственными заболеваниями.



Аневризма — это выпячивание стенки артерии (реже — вены) вследствие её истончения или растяжения

Неразорвавшиеся аневризмы часто не имеют симптомов, но могут вызывать локальную головную боль, боль за глазами, расширение зрачков, искажения зрения. Разрыв аневризмы головного мозга может сопровождаться локальной головной болью, тошнотой, рвотой, двоением в глазах, светобоязнью.

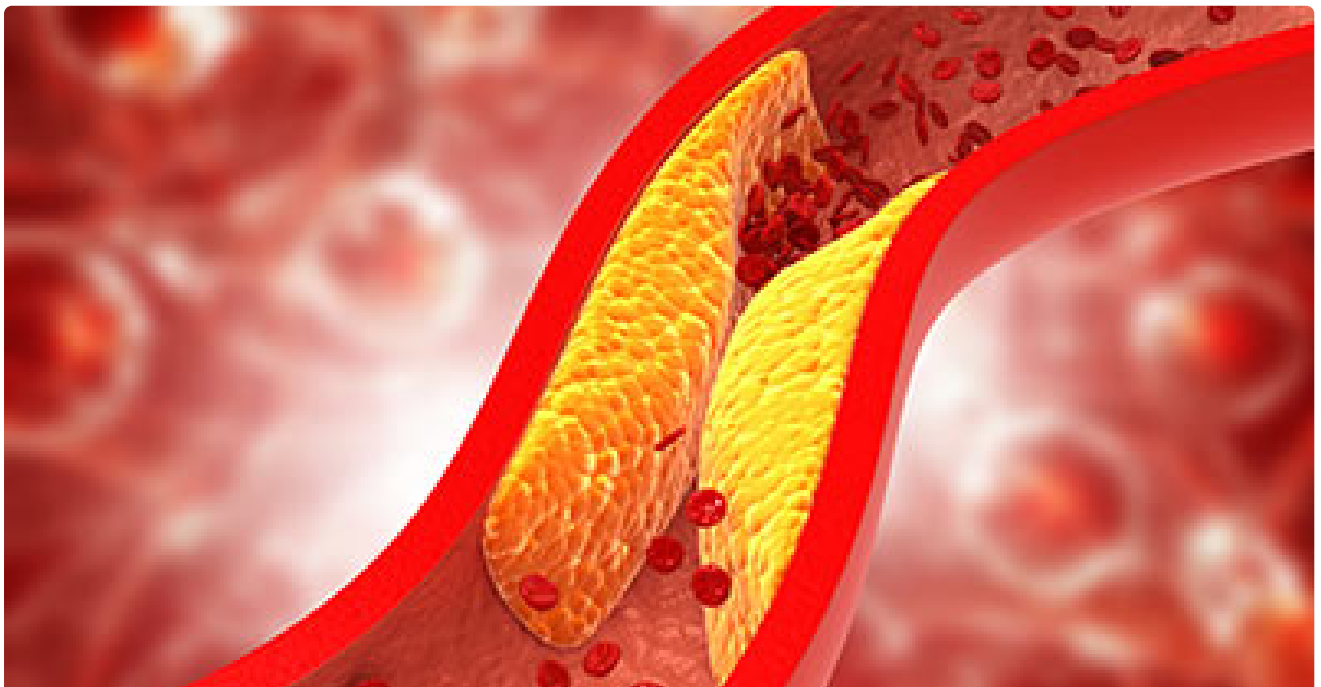
Риск разрыва аневризмы увеличивается с возрастом и при хронических патологиях сосудов (например, при повышенном артериальном давлении, атеросклерозе).

Сосудистые мальформации — переплетение небольших артерий и вен с образованием «сосудистого клубка». Патология может возникать из-за неправильного формирования сосудов во время внутриутробного развития, в результате травмы из-за некоторых наследственных заболеваний, например поликистозной болезни почек. Переплетённые сосуды более подвержены кровоизлияниям, сужениям и разрывам.

Модифицируемые факторы риска

К модифицируемым факторам риска (таким, которые можно контролировать нелекарственным, медикаментозным или хирургическим путём) относят состояния, вызванные нездоровым образом жизни или некомпенсированными хроническими заболеваниями.

Атеросклероз сосудов головного мозга развивается из-за нарушения жирового обмена: **холестерин** и некоторые другие фракции «вредных» жиров оседают на стенках сосудов, постепенно формируя утолщения, которые препятствуют нормальному движению крови. В некоторых случаях просвет сосудов может быть перекрыт практически полностью.



При атеросклерозе человек начинает «хуже соображать»: ухудшается память, снижается работоспособность, сложнее даётся учёба, повышается утомляемость, появляются головные боли. Постепенно — в течение нескольких лет — заболевание прогрессирует, принимая жизнеугрожающую форму: при значительном сужении сосудов может развиваться инсульт или инфаркт. Крупная бляшка может фрагментироваться, поступать в кровоток и перекрывать просвет более мелкого сосуда — тогда развивается эмболия.

Развитию атеросклероза способствуют как наследственные факторы, так и нездоровый образ жизни — некачественное питание, курение, низкая физическая активность. Вылечить заболевание полностью невозможно, но, скорректировав образ жизни — питание, сон, физические нагрузки — и избавившись от вредных привычек, можно в значительной мере замедлить его течение. Назначение специальных лекарственных препаратов — статинов — также замедляет рост атеросклеротических бляшек и уплотняет их, снижая риск их фрагментации.

Гипертоническая болезнь — распространённое хроническое заболевание, которое сопровождается повышенным артериальным давлением, часто с регулярными сильными перепадами давления. Развитию заболевания способствует наследственная предрасположенность, возраст старше 60 лет, повышенный уровень холестерина и нездоровый образ жизни.

О повышении давления могут говорить такие симптомы, как **головная боль**, **шум в ушах** (тиннитус), сердцебиение, **одышка**. Но часто заболевание протекает бессимптомно: человек может даже не подозревать, что артериальное давление резко повысилось или постоянно держится выше нормы за счёт того, что рецепторы, отвечающие за то, как ощущается давление, со временем теряют чувствительность.

Но отсутствие выраженных симптомов не означает, что опасности для здоровья нет: сосуды от перепадов давления меняют свои свойства — становятся менее эластичными, уплотняются, сужаются, нарушая или полностью перекрывая ток крови.

Фибрилляция предсердий — это один из наиболее распространённых видов аритмий и значимый фактор развития инсульта. При фибрилляции — ускоренном и неритмичном сокращении предсердий — повышается риск образования тромбов в левом предсердии, что может приводить к эмболическому инсульту (состоянию, при котором тромб формируется в кровеносных сосудах вне мозга и приносится в мозговые сосуды с кровотоком).

Наиболее часто патология встречается у мужчин старшего возраста, страдающих сердечно-сосудистыми или эндокринными заболеваниями (патологии клапанов сердца, артериальная гипертензия, нарушения работы щитовидной железы, сахарный диабет).

Стеноз сосудов головного мозга — это сужение просвета артерий внутри черепа или на подходе к нему.

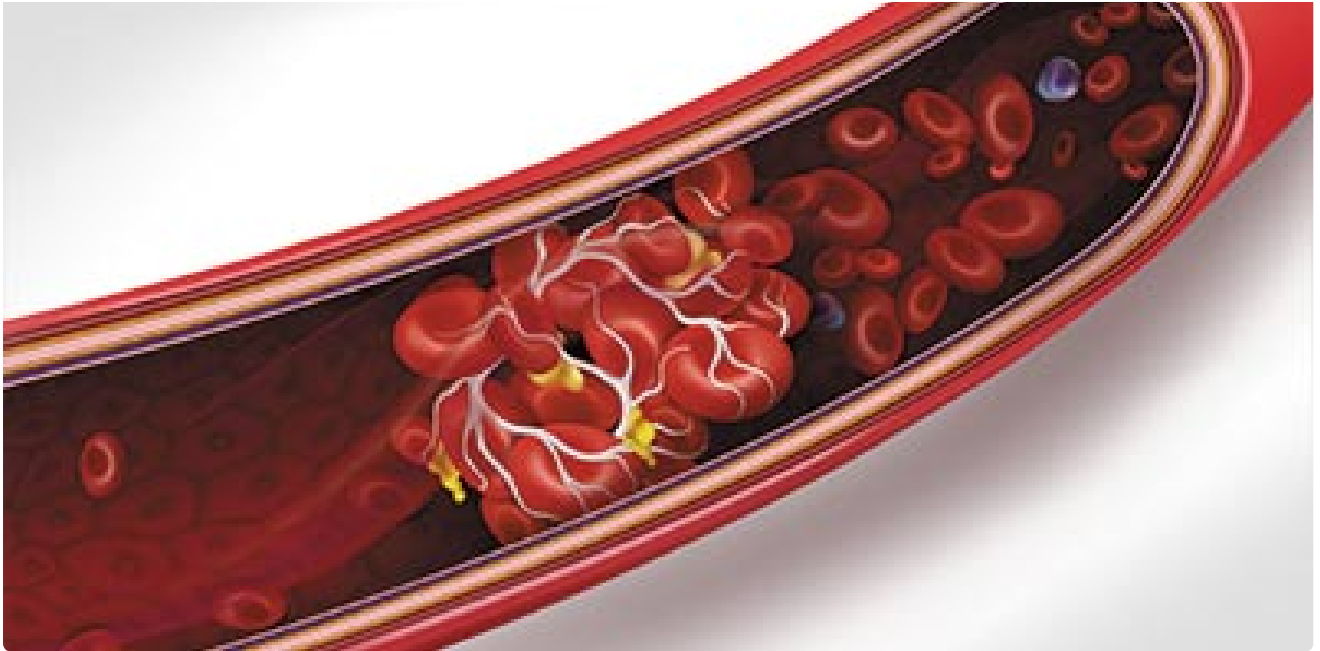
Стеноз может долгое время никак себя не проявлять, но при этом патология выступает причиной 30% инсультов и 50% случаев хронической ишемии (то есть недостатка кислорода и питательных веществ) головного мозга.

Возможные симптомы стеноза — это преходящее, повторяющееся, постепенно прогрессирующее онемение одной или обеих рук, онемение лица, искажения зрения, косоглазие, нарушение речи (или её восприятия), головокружение, внезапная головная боль, шум в ушах, неловкость движений.



Косоглазие — один из симптомов стеноза сосудов головного мозга

Тромбоз сосудов головного мозга — это закупорка кровеносного сосуда сгустком крови (тромбом), который формируется на его изменённой или повреждённой стенке. Тромб постепенно растёт и перекрывает (частично или полностью) просвет сосуда, вызывая опасное для жизни состояние.



Тромб формируется на повреждённой стенке сосуда и может перекрыть кровоток

Тромбоз может возникать независимо от возраста (но чем человек старше, тем выше риск патологии) на фоне сердечно-сосудистых заболеваний (гипертония), воспалительных процессов (отит, **синусит**, **менингит**), травм головы, патологий крови (повышенная свёртываемость), некоторых хронических заболеваний (сахарный диабет) и нездорового образа жизни (недостаточная физическая активность, курение, несбалансированный рацион).

Симптомами тромбоза могут быть сильная головная боль, головокружение, потеря равновесия, нарушения зрения, сужение зрачков, слабость, покалывание и снижение чувствительности и движений отдельных участков лица, шеи, рук.

Эмболия сосудов головного мозга — это состояние, при котором тромб или частицы холестериновых бляшек, свободно путешествующие с кровотоком, перекрывают сосуд, вызывая нарушение питания мозга. Основной фактор риска — фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия).

При эмболии возможны такие симптомы, как слабость и головокружение, головная боль, ухудшение координации движений, обморочное состояние. В целом набор симптомов тот же, что и при тромбозе мозговых артерий.

Причины заболеваний сосудов

Патологии, которые могут приводить к сосудистым заболеваниям головного мозга:

- атеросклероз;
- аритмии;
- заболевания почек;
- наследственная предрасположенность: если у одного или обоих родителей есть сердечно-сосудистые заболевания, велика вероятность их развития и у детей;
- нарушение обмена веществ, в том числе липидного обмена, сахарный диабет;
- склонность к тромбообразованию (часто наблюдается при наследственных коагулопатиях, диабете или при нарушении питьевого режима);
- ожирение;
- врождённые аномалии сосудов.

Контроль сосудистых патологий позволяет предупредить развитие осложнений и катастроф.

Также на развитие заболеваний может влиять образ жизни и общее состояние организма.

Поведенческие факторы, влияющие на развитие сосудистых заболеваний:

- курение — приводит к спазму сосудов и снижению их эластичности;
- алкогольная зависимость — провоцирует резкие колебания давления;
- стресс приводит к спазму сосудов, повышению артериального давления;
- нездоровое питание — приводит к нарушению обменных процессов; повышению концентрации холестерина в крови;
- отсутствие адекватных физических нагрузок — может приводить к снижению мышечной массы, увеличению веса, повышению артериального давления, развитию метаболического синдрома;
- нарушение питьевого режима — повышает вязкость крови.

Симптомы заболеваний сосудов головного мозга

Симптомы заболеваний сосудов головного мозга часто схожи. Это объясняется тем, что независимо от механизма они провоцируют одни и те же процессы в мозге: ухудшение питания, кислородное голодание, а в острых случаях — отмирание клеток или

минут.

Симптомы острого нарушения мозгового кровообращения:

- внезапное нарушение речи;
- трудности восприятия речи;
- потеря сознания;
- искажение зрения;
- мушки или цветные пятна перед глазами;
- двоение в глазах;
- сужение или расширение зрачков;
- головокружение с тошнотой и рвотой;
- психоэмоциональное возбуждение или угнетение сознания;
- асимметрия лица (при разговоре, мимике, в покое);
- ограничение подвижности, слабость в одной или обеих конечностях;
- нарушение чувствительности отдельных участков тела (онемение лица, покалывание в лице, туловище, конечностях).



Выраженная асимметрия лица может свидетельствовать об остром нарушении мозгового кровообращения

исхода.

Хронические патологии сосудов головного мозга менее заметны: они могут развиваться годами и человек долгое время может воспринимать их как вариант нормы или индивидуальную особенность.

Симптомы хронического нарушения мозгового кровообращения:

- постепенное ухудшение памяти;
- общая слабость;
- шум в ушах (тиннитус);
- головная боль;
- боль за глазами;
- ухудшение памяти;
- снижение работоспособности;
- неловкость, нарушение координации движений;
- потеря равновесия;
- утомляемость.

Диагностика заболеваний сосудов головного мозга

При подозрении на заболевания сосудов головного мозга нужно обратиться к терапевту, а затем к неврологу. Врач проведёт осмотр и при необходимости направит к смежным специалистам — кардиологу, сосудистому хирургу.

При физическом осмотре для диагностики сосудистых заболеваний измеряют давление и частоту пульса. Также врач проводит тесты, чтобы исключить неврологические, двигательные и сенсорные нарушения.

Лабораторные исследования позволяют оценить состояние сосудов и риск развития сосудистых патологий.

Липидный комплекс (липидограмма)

139 бонусов

 1 день

Вен. кровь 270 ₹

Вредный и полезный холестерин

59 бонусов

590 ₹



В корзину

 1 день

Вен. кровь 270 ₹

Свертывающая система крови

159 бонусов

1 590 ₹



В корзину

 1 день

Вен. кровь 270 ₹

Чтобы исключить атеросклероз, аневризмы и другие патологии, врач может назначить **инструментальные исследования** — ультразвуковую доплерографию сонных артерий, МР- или КТ-ангиографию головного мозга (исследование сосудов головного мозга).

При подозрении на аневризмы и мальформации также назначают компьютерную или магнитно-резонансную ангиографию головного мозга.

Лечение заболеваний сосудов головного мозга

При атеросклерозе тактика лечения зависит от того, насколько сильно сужены просветы

Если сужение значительное, предлагают хирургическое лечение (каротидная эндартерэктомия) — удаление бляшки на стенке артерии через надрез.

Также возможны другие методы — каротидная ангиопластика и стентирование, они используются, если эндартерэктомия у данного пациента считается слишком рискованной. Во время ангиопластики врач вводит в артерию баллонный катетер и расширяет просвет артерии, сплющивая бляшку. Затем проводится стентирование — внутрь сонной артерии вставляется тонкая металлическая сетчатая трубка, чтобы зафиксировать сосуд в «раскрытом» состоянии. Такая процедура позволяет восстановить проходимость артерии и кровоснабжение мозга.

При гипертонической болезни назначают препараты для контроля артериального давления. Важную роль в терапии гипертонии играет нормализация веса, введение умеренных, но регулярных физических нагрузок, соблюдение диеты.

При аневризмах показано очень тщательное динамическое наблюдение. Если есть угроза разрыва сосуда, проводят хирургическое лечение — клипирование аневризмы: повреждённый участок изолируют при помощи специальных зажимов. Операция по клипированию проходит со вскрытием черепа и возможна только в том случае, если поражённый участок расположен в доступном для операции месте.

Для лечения аневризмы также используется менее инвазивный метод — эндоваскулярная терапия. Технически этот метод напоминает стентирование — с помощью катетера в артерию вводится спираль, которая заполняет просвет аневризмы и фиксирует стенки сосуда изнутри, снижая риск разрыва.

При тромбозе мозговых артерий назначают медикаментозное лечение: применяются препараты, растворяющие тромбы и нормализующие мозговое кровообращение (тромболизис).

Иногда показано хирургическое лечение — в этом случае извлечение тромба проводится в условиях специализированной рентгенооперационной.

При аритмиях назначают лекарства, нормализующие частоту и ритм сердца, и препараты, препятствующие образованию тромбов (антикоагулянты).

Осложнения заболеваний сосудов головного мозга

Острые или хронические заболевания сосудов головного мозга опасны тем, что могут

процессами в организме или к смерти.

Чем дольше патологии сосудов остаются без лечения, тем выше вероятность осложнений. В случае с острыми состояниями счёт идёт на часы и даже минуты.

Источники

1. Брисман Д. Л., Сонг Й. К., Ньюэлл Д. У. Внутричерепные аневризмы // РМЖ. 2008. № 9. С. 581.
2. Mitchell L. B. **Фибрилляция предсердий** / Справочник MSD. 2021.

Частые вопросы

Какие бывают заболевания сосудов головного мозга?

Кто лечит сосуды головного мозга?

Справочник

Заболевания

Информацию проверил
врач-эксперт



Екатерина Демьяновская

Врач-невролог, кандидат медицинских наук

Оцените статью:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Полезная статья? Поделитесь в социальных сетях:



Не нашли ответ на свой вопрос?

Напишите нам — мы постараемся дополнить статью или передадим вопрос врачу-консультанту. Это бесплатно.

Имя

Адрес электронной почты

Текст

☐ Даю согласие на [обработку персональных данных](#).

Отправить

Отправляя заявку, вы принимаете условия Правил «Гемотест Бонус»

ВАЖНО

врач на основании всех имеющихся у него данных.

Популярные статьи

Бляшки и красные пятна на коже

Кортизол

Аппендицит

Строение женских половых органов

Задержка месячных

Вам телеграм.

Telegram-канал,
которому, на наш взгляд,
можно доверять

Не нашли что искали?
Напишите нам,
и мы постараемся вам помочь

Оставить вопрос

Закажите
исследования
с выездом
на дом

Запишитесь
на онлайн-
консультацию
специалиста

Проверьте
скидки
и предложения
от партнёров

Используйте
бонусы
в программе
лояльности

К началу страницы

ПАЦИЕНТАМ БИЗНЕСУ КОМПАНИЯ

Каталог анализов	COVID-19
Акции и скидки	Медицинские услуги
Адреса отделений	Гемотест Клуб + Бонус
Выезд на дом	Онкодиагностика
Телемедицина	Вопрос врачу
Подготовка	Налоговый вычет
Результаты анализов	Обратная связь

[Карта сайта](#) [Оплата и возврат](#) [Правовая информация](#) [ЦУР](#) [Использование Cookie](#)
[Возрастное ограничение 12+](#)

© ООО «Лаборатория Гемотест». Все права защищены.